

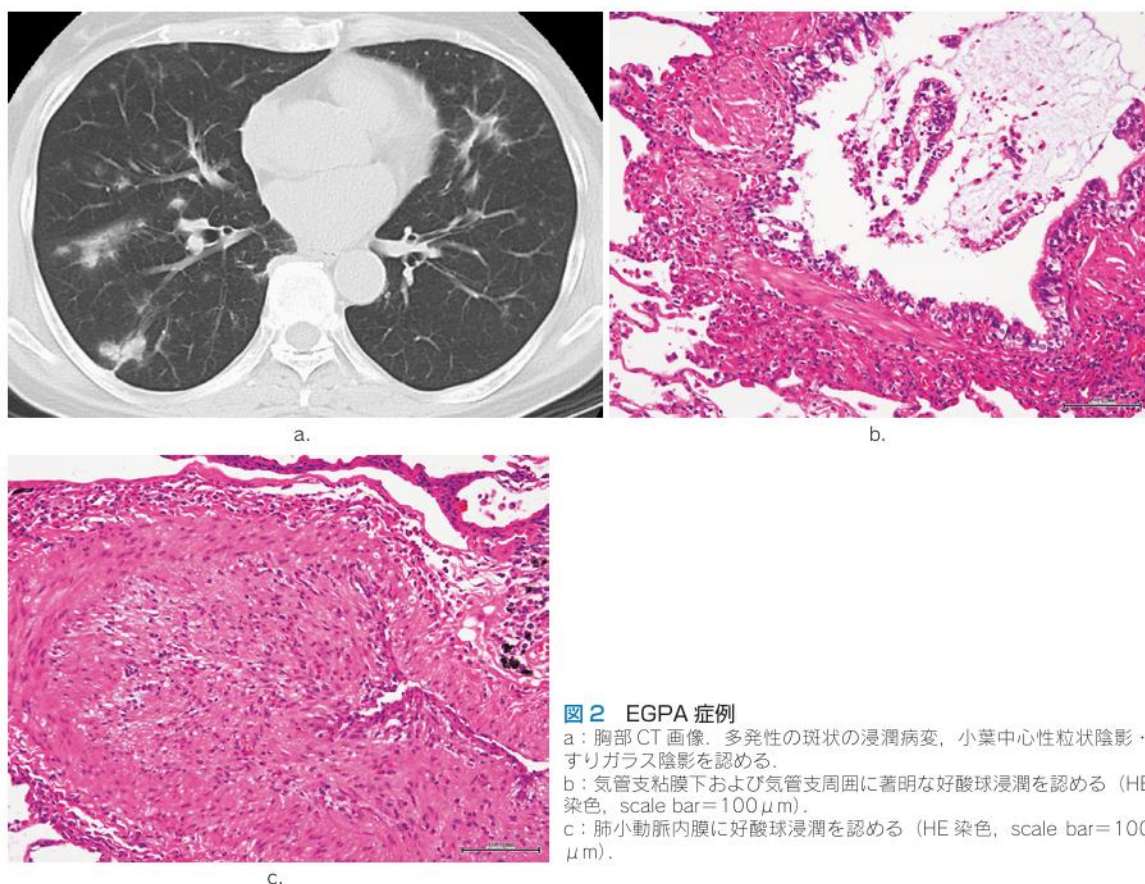


図2 EGPA 症例

a: 胸部 CT 画像。多発性の斑状の浸潤病変，小葉中心性粒状陰影・すりガラス陰影を認める。
b: 気管支粘膜下および気管支周囲に著明な好酸球浸潤を認める（HE 染色，scale bar=100 μm）。
c: 肺小動脈内膜に好酸球浸潤を認める（HE 染色，scale bar=100 μm）。

治療

a 寛解導入療法

寛解導入療法の標準治療はグルココルチコイド (GC) + cyclophosphamide (CY) であり，経口投与よりも静注パルス療法 (IVCY) が優先される。AAV では診断，臓器障害の程度，重症度などを評価後に開始され，多くは3～6ヵ月後に効果判定を行う。無効症例では再び寛解導入療法を検討する。

rituximab (RTX) の使用に関しては，大規模な臨床試験が行われ，RTX は CY と同等の高い寛解導入率と同程度の安全性が示された³⁾。本邦では高齢者の AAV 患者の割合が多いことから，重症感染症に注意しながら十分な知識と経験を持つ医師のもとで投与されるべきである。さらに，ステロイド減量効果を期待して，あるいは急速に腎機能が悪化している場合には，GPA，MPA の寛解導入に選択的 C5a 受容体拮抗薬である avacopan と RTX/CY との併用が考慮される⁴⁾。また，RPGN を含む腎不全やびまん性肺出血を合併した際は，血漿交換療法の併用（保険適用外）を検討する。さらに従来療法に抵抗性を示す EGPA の末梢神経障害を合併した際は，免疫グロブリン大量

療法 (IVIG) (保険適用) を検討する⁵⁾。最近，EGPA 患者を対象とした国際共同第Ⅲ相試験 (MEA115921) において，mepolizumab (抗 IL-5 抗体) は EGPA 患者の 32% を寛解させ，44% で経口ステロイド薬を減量，18% で中止⁶⁾，また benralizumab (抗 IL-5α 受容体抗体) も，mepolizumab 同等の寛解率が示された⁷⁾。

b 寛解維持療法

寛解導入後は，prednisolone (PSL) 5～10 mg/日で維持し RTX による治療継続が推奨されている (24～48 ヶ月)。RTX を維持に用いる試みも行われている。寛解維持療法は少なくとも 18～24 ヶ月行うことが推奨されている。

文 献

- 1) 有村義宏ほか (編) : ANCA 関連血管炎診療ガイドライン 2017, 診断と治療社, 2017
- 2) Jennette JC, et al : Arthritis Rheum 65 : 1, 2013
- 3) Stone JH, et al : N Engl J Med 363 : 221, 2010
- 4) Jayne DR, et al : N Engl J Med 384 : 599, 2021
- 5) Taniguchi M, et al : Allergol Int 56 : 97, 2007
- 6) Wechsler ME, et al : N Engl J Med 376 : 1921, 2017
- 7) Wechsler ME, et al : N Engl J Med 390 : 911, 2024